TEMA 16 · Prevención y promoción de la salud. Detección precoz y factores de riesgo por etapas de la vida

Resumen OPE Enfermería SMS · Niveles de prevención, Carta de Ottawa, marco normativo, cribado y escalas, diagnósticos de riesgo, factores de riesgo y cuidados en infancia, adolescencia, edad adulta y vejez, programas del SNS y del SMS

1. Prevención y promoción: conceptos

Nivel (Leavell y Clark)	Periodo	Objetivo	Ejemplos
Primaria	Prepatogénico	**Reducir la incidencia**	Vacunas, EpS, cloración del agua, preservativo
Secundaria	Patogénico **subclínico**	**Detección precoz**, reducir la **prevalencia**	**Cribados**: mamografía, citología, prueba del talón, toma de TA en sanos
Terciaria	Enfermedad establecida	Reducir **complicaciones y secuelas**	Rehabilitación tras ictus o IAM, prevención del **pie diabético**, inhaladores en EPOC
Cuaternaria (Marc Jamoulle)	—	Evitar la **iatrogenia** y la sobremedicalización	No dar antibióticos en virasis, desprescribir

- **Promoción de la salud** (**Carta de Ottawa, 1986**): "proceso que permite a las personas **incrementar el control sobre su salud** para mejorarla". Enfoque positivo y **salutogénico**; la salud como **recurso para la vida cotidiana**. Antecedente: **Alma-Ata (1978)**, "Salud para todos en el año 2000".
- **5 áreas de acción de Ottawa**: **políticas públicas saludables**, **entornos favorables**, **acción comunitaria**, **aptitudes personales** (EpS) y **reorientación de los servicios sanitarios**.

	Prevención	Promoción
Enfoque	Defensivo: evitar la enfermedad (modelo biomédico)	Positivo: ganar salud (salutogénico)
Diana	Grupos de riesgo o enfermos	**Toda la población**
Eje	**Factores de riesgo**	**Determinantes sociales**
Éxito	Menos morbimortalidad	Más calidad de vida y equidad

- Son **complementarias**: en la misma consulta se mide la TA (prevención) y se da consejo de ejercicio (promoción).

2. Marco normativo y estratégico

- **Ley 14/1986, General de Sanidad**: el sistema se orienta prioritariamente a la promoción y la prevención. **Ley 16/2003**: prevención y promoción en la cartera de servicios. **Ley 33/2011, General de Salud Pública**: la ley específica de salud pública.
- **Estrategia NAOS (2005)**: Nutrición, Actividad física y prevención de la Obesidad, sobre todo en la **infancia** y la juventud. Programas municipales y escolares **THAO** y **NEREU** (obesidad infantil).
- **Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS (2013)**: enfermedades crónicas; áreas: **alimentación, actividad física, bienestar emocional, tabaco y alcohol**.
- Región de Murcia: **Ley 4/1994** de Salud; Ley 5/2001 de personal estatutario del SMS. **4 programas del SMS**: **salud infantil**, **salud escolar**, **atención al adulto** y **atención a las personas mayores** (este incluye el **apoyo al cuidador familiar**).
- **PAPPS**: programa de la **semFYC**; **no es una ley**, sino un documento de consenso que fija cribados y consejos por edades. Las **alertas o fichas preventivas** en la historia electrónica aumentan los cribados (Brotons, 1996).

3. Detección precoz (cribado)

- Pruebas sistemáticas en personas **asintomáticas**: siempre **prevención secundaria**.

- **Criterios de Wilson y Jungner (OMS)**: enfermedad importante con **fase latente reconocible**; el tratamiento precoz debe ser **más eficaz** que el tardío; prueba válida, fiable, segura, **aceptable** y coste-efectiva; recursos para confirmar y tratar los positivos; programa **continuo**.
- **Sensibilidad**: detecta a los **enfermos** (evita falsos negativos; la deseable en un cribado). **Especificidad**: identifica a los **sanos** (evita falsos positivos).
- **Cribado oportunista**: aprovechar cualquier contacto (TA, glucemia, IMC, escalas).

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! "Detección precoz de la diabetes" = secundaria; "detección precoz del **pie diabético** en un diabético" = **terciaria** (se busca la complicación).

Necesidad	Escalas
Riesgo de **UPP**	**Norton**, **Braden** (incluye **fricción y cizallamiento**)
Riesgo de **caídas**	**Downton**, **Morse**; **Tinetti** (marcha y equilibrio)
Cognitivo	**MEC de Lobo** (adaptación española del Mini-Mental; 35 puntos frente a 30), **Pfeiffer**, test del reloj
Depresión	**Yesavage** (anciano), Goldberg (ansiedad y depresión)
Alcohol	**AUDIT** (AUDIT-C, versión corta)
Nutrición del anciano	**MNA** (patrón oro)
Sobrecarga del cuidador	**Zarit**
Infancia	Percentiles, test de **Denver** (psicomotor), **M-CHAT** (autismo)

- **Diagnósticos de riesgo NANDA-I**: "Riesgo de… r/c factores de riesgo"; **nunca llevan "m/p"** (no hay signos porque el problema aún no existe). Ej.: Norton con alto riesgo → **Riesgo de deterioro de la integridad cutánea**; **Riesgo de caídas** (NOC: conducta de prevención de caídas; NIC: prevención de caídas). **NIC** = acciones de la enfermera; **NOC** = resultados del paciente.

4. Infancia

- **Obesidad infantil**: dieta, sedentarismo y **pantallas**, **déficit de sueño** (factor de riesgo, no protector), bajo nivel educativo materno y bajos ingresos. **Factor protector principal: lactancia materna**.
- **Accidentes**: **primera causa de muerte a partir del primer año** en países desarrollados (tráfico, ahogamiento, caídas, intoxicaciones, quemaduras). Prevención: supervisión, **sistemas de retención infantil**, hogar seguro.
- Desarrollo psicomotor: prematuridad, bajo peso, hipoxia → derivación a **Atención Temprana**. Caries, infecciones (no vacunación, guardería).
- Cuidados (**Programa del Niño Sano**): percentiles, EpS familiar, NAOS; **coberturas vacunales > 95%**; **lactancia materna exclusiva 6 meses** y complementada hasta los 2 años o más; enfermera escolar.

5. Adolescencia

- **Alcohol** (sustancia más consumida; patrón ***binge drinking***, atracón tipo "botellón"), **cannabis** (droga **ilegal** más consumida), tabaco y vapeadores.
- **Salud mental**: ansiedad, depresión, **conducta suicida** (en aumento), **TCA** (pico de inicio, sobre todo en chicas). Conductas sexuales de riesgo (ITS, embarazo), **ciberacoso** (anonimato, difusión masiva, acceso 24 horas), sedentarismo y accidentes de tráfico.
- Cuidados: **confidencialidad**, enfoque no directivo, **entrevista motivacional** (de elección, p. ej., ante consumo de cannabis), **consejo breve** (3-5 minutos; lo más coste-efectivo en tabaco), **educadores de iguales**, programa **"Salud y Escuela"** (enfermera de referencia en los institutos), habilidades para la vida (asertividad), doble método, seguridad vial.
- A partir de los **16 años** (o menor maduro), las consultas son confidenciales salvo riesgo grave.

6. Edad adulta

- **Riesgo cardiovascular**: **HTA** (un tercio de los adultos, muchos sin diagnosticar), **obesidad** (> 50% con exceso de peso; el **perímetro abdominal** es el mejor predictor de riesgo, mejor que el IMC), **diabetes tipo 2** y **dislipemia**. Tabaco (20-25%), alcohol, sedentarismo, abandono de la dieta mediterránea, estrés y riesgos laborales.
- **Actividad física (OMS)**: **≥ 150 minutos semanales moderados o 75 minutos vigorosos**.
- Riesgo global: tabla **SCORE** (mortalidad cardiovascular a 10 años, Europa) y **REGICOR** (adaptación **española** de Framingham, Girona).
- Tabaco: **intervención breve de las 5 aes** (averiguar, aconsejar, acordar, ayudar, asegurar el seguimiento).

Cribado poblacional (cartera común)	Población	Prueba
Mama	Mujeres de 50-69 años	Mamografía cada 2 años
Cérvix	25-34 años / 35-65 años	Citología cada 3 años / **test de VPH** cada 5 años
Colorrectal	50-69 años	**Sangre oculta en heces cada 2 años**
Próstata	—	**Sin cribado poblacional** (sobrediagnóstico y sobretratamiento)

- Las consultas de enfermería logran buena adherencia y control en crónicos; campañas fuera del centro para captar a adultos sanos.

7. Personas mayores

- Objetivo: **prevenir la dependencia** y mantener la funcionalidad; **envejecimiento activo** (OMS: optimizar salud, **participación** y seguridad).
- **Caídas**: un tercio de los > 65 años al año. Factores **intrínsecos** (sarcopenia, déficits sensoriales, deterioro cognitivo, marcha, **benzodiacepinas**) y **extrínsecos** (alfombras, iluminación, calzado). **Mejor predictor: caída previa**. Consecuencia limitante: **síndrome poscaída** (miedo a caer). Abordaje **multicomponente**: escalas, ejercicio, revisión de fármacos y visita domiciliaria.
- **Delirium**: inicio **agudo**, nivel de conciencia **fluctuante** (frente a la demencia, insidiosa). Desencadenantes: infección urinaria, deshidratación, dolor, sondas, anticolinérgicos. Prevención **no farmacológica**: orientación (reloj, calendario), **gafas y audífonos**, sueño, movilización precoz e hidratación; evitar sedantes y contenciones.
- **Polimedicación: ≥ 5 fármacos**; criterios **STOPP/START** (benzodiacepinas, anticolinérgicos, AINE). **Conciliación de la medicación** al alta.
- Malnutrición (**MNA**), deterioro cognitivo (MEC, Pfeiffer), depresión infradiagnosticada (Yesavage), soledad. Atención al **cuidador** (Zarit, respiro).

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Un diagnóstico de riesgo con "manifestado por" es **falso**.
>
> ! **Primera causa de muerte en niños mayores de 1 año: accidentes.**
>
> ! Anciano hospitalizado que se agita de noche: primero medidas **ambientales y de orientación**, no sedantes ni contención.
>
> ! El PAPPS es de la **semFYC**, no una norma legal.